

권 고

1. 제 목 : 가나다라연구소 연구전담의 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : ㉠병원
3. 내 용

가. 업무개요

가나다라연구소는 '13년도 및 '14년도 ㉠처 대통령 업무보고 「명예로운 ㉡」 실천과 ㉡의료연구기능 강화를 통해 ㉠병원이 국가유공자 최종진료를 담당하는 상급종합병원 수준으로 발전하기 위한 목적을 가지고 '15.6월 「가나다라연구소 설치계획」이 이사회 의결을 통해 설립이 본격적으로 추진되어,

'18년 8월 개소 후 ㉡대상자 관련 질환 연구를 위해 ㉢연구부, ㉣연구부, ㉤연구부, ㉥연구부 등 #개의 연구부를 두고 연구전담의를 운영하고 있습니다.

가나다라연구소 연구의사 운영에 관한 추진경과를 보면, '15.6월 「가나다라연구소 설치계획」(이사회 의결) 시 운영인력 중 연구의사는 [표 1]과 같이 병원 업무와 검무를 통해 운영하는 것으로 계획되었고,

[표 1] 2018년 가나다라연구소 개원 후 인력운영 계획('15.6)

연구소장	연구의사	연구원	약 사	의공학자	행정인력	합 계

주1) ()는 병원업무와 검무 인력

'16.4월 ㉠병원에서 본사 및 ㉠부에 보고한 「가나다라연구소 운영 추진경과 보고」에서도 연구의사 #명을 병원업무와 검직으로 운영하는 것으로 보고하는

등 임상 의사가 **가나다라**연구소 인프라를 통해 진료와 연계된 연구를 수행하여 ㉔대상 연계 연구 특화 및 연구소 운영 비용(인건비)에 대한 효율성을 기하는 계획을 수립하였습니다.

그러나 그 이후 '17.9월 본사 ㉑예산부에서 ㉒부에 **가나다라**연구소 정원 요청 시 의사직 #명(연구소장 #명, ㉓뱅크센터#명, ㉔연구부 #명, ㉕연구부 #명, ㉖연구부 #명, 재활보장연구부 #명, ㉗센터 #명)을 연구 전담으로 운영하는 것으로 운영 계획을 변경 신청하여 최종 #명이 승인되었고, 그에 따라 '17.12월 **가나다라**연구소 연구 각 부 소속 포함 연구전담의 #명이 정원에 반영되었습니다.

이에 ㉑병원에서는 '18.12월 본사로부터 **가나다라**연구소 정원내 인력채용 승인을 통보 받고 '19.3월 일시 연구전담의 #명을 채용하여 #개 연구부 연구전담의 운영체제를 시작하였습니다.

따라서 ㉑병원 **가나다라**연구소에서는 연구전담의 운영 체계를 통해[표 2]와 같이 연구 각 부에 부여된 ㉔의료 특성화 연구과제 발굴 및 전문 연구 수행을 통하여 연구능력 강화를 시켜나가는 등 궁극적으로 **가나다라**연구소의 설립 목적인 '연구성과가 임상진료, 의료정책에 반영되는 선순환 연구체계'가 정립되도록 기반을 다져나가고 ㉔의료 서비스 질을 향상시켜 나갈 수 있도록 연구전담의 인력 및 연구성과 관리를 해야 합니다.

그런데, **가나다라**연구소 연구전담의 운영 현황을 확인한 결과, 다음과 같은 운영상 문제점이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 가나다라연구소 조직도(4개 연구부)



(가) 연구전담의 연구 기능 부실

가나다라연구소는 중장기적으로 수행되는 연구의 특성을 고려하여 연구전담의 계약 기간을 #년 단위로 하되 연장 계약을 통해 연구의 연속성과 전문성을 기하는 운영체제로 운영하고 있습니다.

따라서 가나다라연구소 개원 후 가나다라연구소 연구 각 분야에서 연구전담의가 ㉠의료 특성화 연구과제 발굴 및 수행 성과를 이뤄내어 체계적으로 연구전담의 운영 체계를 정착시키고 연구능력을 강화 및 확대해 나가는 것이 중요하였습니다.

그런데 '18년 가나다라연구소의 개원 후 '24년 현재까지 연구전담의 채용 및 운영 현황을 확인한 결과, [표 3]과 같이 '19년 연구소 개소 직후 채용된 #명의 연구전담의가 임상 진료과와의 연구 협조 애로 등 각각의 사유로 #명은 #개월만에 퇴사, #명은 #년 계약기간 후 퇴사등으로 초기 채용한 연구전담의 #명 전원이 #년 이내 퇴사를 함으로써 가나다라연구소 개원 초기 연구전담의 중심의 연구 기반 체계 구축에 실패하였고,

[표 3] **가나다라연구소 연구전담의 운영 현황('18~'24년)**

구 분	성 명	입사일	퇴직일	근무기간	이직 기관	비 고

그 이후에도 '20.3월 ①연구부 연구전담의 #명(#년 근무), '22년 ⑨연구부 #1명(#년 근무), '23년 ①연구부 #명(#개월) 등 연구부별 산발적으로 연구전담의를 채용·운영하였으나 '20.3월 채용된 ⑥연구부 연구전담의 #명(現 ㉟뱅크장 겸직)을 제외한 대부분의 연구전담의가 #년 내 잦은 퇴사로 핵심인력을 기반으로 한 연구능력 점진적 강화체계를 만들어 나가는데는 한계가 있었던 것으로 확인되었습니다.

특히 가나다라연구소는 각 연구부 별로 전문성 있는 연구를 수행하도록 구축되었으나, ㉟의료 특화 연구에 대한 구체적이고 체계화된 계획 및 전략이 없고 채용된 연구전담의 별로 부여된 연구 역할과 임무 및 수행에 대한 지침이 없어, [표 4]와 같이 개인 논문 작업 또는 연구 책임자가 아닌 임상 진료과 연구과제의 연구 참여원으로서 보조적 역할을 주로 수행하고 있으며, 의료질평가 연구개발 영역 등급에 영향을 미치는 지식재산권(특허) 획득 실적은 전무한 등 연구전담의 인력을 기반으로 하는 ㉟의료 특성화 연구 수행 기능은 미미한 것으로 확인되었습니다.

[표 4] 가나다라연구소 연구전담의 연구성과

구 분	성 명	입사일	퇴직일	외부과제 책임자 수행	논문수	특허등록 수

이와 같이 가나다라연구소의 연구전담의의 연구역할 및 성과가 부실한데 비하여, 연구전담의 운영 비용(인건비)은 [표 5]와 같이 개원 후 현재까지 고정비용인 총 인건비의 #% 수준('23년)으로 지속 확대되어 가나다라연구소 적자 운영에 중요 요인으로 작용되고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 5] 가나다라연구소 연구전담의 운영 비용(인건비)

(단위 : 백만원)

구 분	영업 수익	영업 비용	영업 손익	총인건비 (A)	연구전담의 인건비 (B)	비 율(B/A)

(나) 연구전담의 연구 임상진료 연계 미흡

가나다라연구소는 '연구성과가 임상진료, 의료정책에 반영되는 선순환 연구 체계 정립'을 기본 운영방향(가나다라연구소 기본 운영계획('18.5.제#차 이사회보고))으로 하여 설립되었습니다.

따라서 가나다라연구소에서는 ㉔ 대상 환자의 임상진료를 기반으로 연구 성

과를 창출하고, 그 성과가 ㉔의료정책에 반영될 수 있도록 하는 연구 체계를 정립해 나가야 하며,

특히 연구전담의 운영 체계를 도입한 만큼 병원업무와 겸직으로 운영하려던 초기 계획보다 진료와 연구 수행이 균형 잡힌 체계로 운영 될 수 있도록 제도적 장치 마련 및 운영 관리를 해야 합니다.

그런데, '17년 연구전담의 정원 확보 이후 의사직을 연구전담의 체제로 운영하는 것으로 시작한 이래 현재까지 연구전담의 채용·운영 시 임상진료(세션 운영 등)에 대한 필수 조건 없이 운영하고 있었으며,

그 결과 [표 6]과 같이 그동안 채용된 연구전담의의 업무 중 임상진료가 없거나 # 세션 운영 등 최소한의 임상진료만을 운영하여, 임상진료가 없는 경우 진료과와의 협조 애로 등으로 임상 데이터를 활용하지 못하거나, 최소한의 세션으로 운영한 경우에도 연구가 미진하거나 가시적인 성과 창출이 없어 연구전담의 운영 체계 본래의 목적인 진료와 ㉔ 특화 연구 수행의 균형 잡힌 연계 연구 성과를 내지 못하는 것으로 확인되었습니다.

[표 6] 연구전담의 진료 세션 현황('19~'24.4월)

구 분	성 명	입사일	퇴직일	진료과	운영세션	비 고

더욱이 ㉔병원 의생명연구원, 국립 ㉔, ㉔병원 등 국내 주요 연구기관에서는

연구 인력으로 임상연구자(MD)와 연구교수(원)(Ph.D) 등의 협업 연구체제로 운영하여 임상진료를 기반으로 한 연구전문성을 확보하는데 반해, **가나다라**연구소와 같이 연구전담의 체제로 운영하는 곳은 유일하여 연구전담의 운영의 당위성과 효과성에 대한 검토가 필요한 것으로 확인되었습니다.

(다) 연구전담의 연구 성과 유도 제도적 장치 운영 미흡

가나다라연구소에서는 연구전담의 보수 지급 방식으로 ①병원 전문의 보수체계(기본연봉+성과연봉+부가수당+퇴직충당금)를 따르되, 성과연봉 항목 중 '진료성과급'의 경우 [표 7]과 같이 **가나다라**연구소 연구전담의 별도의 평가 기준을 마련하고 운용하고 있습니다.

[표 7] 연구전담의 진료성과급 평가항목 및 배점('23년 하반기)

항 목	논 문	외부과제 수 행	특 허	IRB 건수	학술 활동	병원 직·간접 기여도	비계량평가 (근태,정책참여도)	
							연구 소 장 평 가	병 원 장 평 가

따라서 **가나다라**연구소의 연구전담의 평가는 연구 성과 창출을 독려할 수 있도록 연구 성과 정도에 따라 차등이 되도록하고, 운영의 효율성과 ② 특화 연구 성과의 질적 향상을 위해 외부과제(국책과제 등), 진료 세션 개설수 등 성과를 강화하고 확대될 수 있도록 유도해 나가는 평가 방식으로 운영되어야 합니다.

그런데 '19~'23년간 **가나다라**연구소 연구전담의 진료성과급 평가결과를 확인한 결과, ② 특화 연구와 연관성이 크게 없이 개인적으로 진행중이던 연구 주제가 주를 이루는 '논문' 영향력 지수 배점을 #점으로(기존 #점→조정 #점) 하여 그 비중이 가장 높은 반면, 기관의 ② 특화 연구 성과나 외부과제 간접비 수주 등 연구수익과 관련된 '외부과제수행', '병원 직·간접 기여도창출(세션 개설)'에 대한

비중은 상대적으로 낮아 **가나다라**연구소 운영 목적에 부합하는 특화 연구를 수행하도록 하는 성과 유도가 크지 않고 연구전담의 편의성 위주로 운영하고 있는 것으로 확인되었습니다.

더욱이 외부과제(국책 및 임상연구과제 등) 수행 성과는 [표 8]과 같이 연구 책임자로서 연구 수주 규모를 1천만원 이상을 만점으로 설정하였으나, '19~'23년간 외부과제를 책임자로 수행하여 성과 점수를 획득한 경우는 기간 전체 연구전담의 #명 중 #명을 제외하고는 실적이 전무하였습니다.

[표 8] 연구전담의 진료성과급 외부과제 수행 평가 기준

구 분	세부지표	배점	산출방법

또한 평가방식도 절대평가가 아닌 상대평가 체계로 운영하여 [표 9]과 같이 '23년 하반기 평가의 경우 평가대상 연구전담의 #명 전원이 #점 미만(평균 #점)으로 성과가 저조함에도 A~C 등급 순차 배정으로 일정 범위내 진료성과급 획득이 담보되어 연구 성과에 대한 동기부여 요소가 없고,

실질적으로 연구 실적이 없어 평가 점수가 사실상 0점에 가까워도 #인 소규모 평가대상에 따라 진료성과급이 지급되는 구조(D등급($\beta \times \# \%$), E등급($\beta \times \# \%$) 배정이 없음)로 연구 성과 창출에 대한 강제성도 미미하여 연구전담의의 적정 연구에 대한 인센티브·패널티 요소도 기능하지 못하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 9] 연구전담의 진료성과급 평가('23년 하반기) 결과

항목	논 문 (35점)	외부과제 수 행 (20점)	특 허 (15점)	병원 직·간접 기여도 (5점)	IRB 건수 (2점)	학술 활동 (3점)	비계량 평가		총점 (등급)
							연구소장 평가 (10점)	병원장 평가 (10점)	
구 분	S등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급			

(라) 총 괄

☐☐☐☐연구소 연구전담의 운영은 초기 운영체계 정착 실패 및 지속적인 연구전담의 이탈, ⑤ 특화 연구 성과가 저조하여 연구전담의를 특징으로 한 연구 기능 체계를 강화하는 데는 한계점이 있는 것으로 확인되면서도, 연구전담의 운영에 대한 타당성 검토나 중장기 운영 전략 없이 ☐☐☐☐연구소 운영 비용의 큰 비중을 점하고 있는 채 운영되고 있습니다.

이에 연구전담의 운영체제에 대한 제도적, 구조적 운영 전략 재설정을 통해 연구 성과가 임상진료, 의료정책에 반영되는 선순환 연구체제로 운영될 수 있도록 운영 방식을 개선할 필요성이 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

(가) 연구전담의 연구 기능 부실 관련

☐☐☐☐연구소에서는 연구전담의 연구 기능 부실 사유에 대해 연구전담의 계약기간을 #년 단위로 운영하여 연구의 지속성과 연속성을 보장해주지 못하였고,

타기관에 비해 낮은 연봉의 계약직으로 고용하여 우수한 연구진의 이탈을 유도하였다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 현재 **가나다라**연구소에서 연간 재계약을 통해 #년, #년 연속 근무를 하면서 연구실적이 있는 연구전담의(#명)와 같이 연구전담의 본인의 선택에 따라 재계약을 통해 지속적인 연구 업무가 가능한 바, 계약직 운영만을 이유로 연구의 연속성과 지속성에 영향을 주어 연구 기능 부실 초래의 주요 요인으로 삼기에는 한계가 있을 것입니다.

(나) 연구전담의 연구 성과 임상진료 연계 미흡 관련

타기관 의학연구소의 경우 수십명의 PhD 확보 및 진료하지 않는 기초의학연구자(MD&PhD)를 늘리기 위하여 노력하는 등 인프라를 통해 연구 전문성을 기하고 있고, **가나다라** 특화 연구라는 주제는 범위와 연구대상자 군이 제한적이므로 학계에 유의한 영향을 끼치는 연구결과를 산출하기 어려우며, 이러한 연구만을 지원한다면 ㉢병원의 위상 제고에 역행하게 될 우려가 있다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 임상 전문의 대우에 준하는 **가나다라**연구소 연구전담의 대우는 타기관 의학연구소 PhD 대우보다 좋아 **가나다라**연구소 지원 가능 범위내 최대한 인프라 강화를 하고 있으며, ㉠병원 임상진료의의 책임연구나 특허 등 연구 실적보다 **가나다라**연구소 연구전담의 연구실적이 더 낮은 것을 고려할 때 연구 인프라 한계로만 연구 실적 부진을 설명하기에는 한계가 있을 것이고,

또한 ㉢ 특화 연구를 수행을 목적으로 설립·운영되는 **가나다라**연구소는 ㉢ 특화 연구가 우선시 되어야 하고 그러한 ㉢ 특화 연구 성과 창출 기반에서 일반 연구 기능이 확대되어 전문성을 길러나가는 것이 운영 목적에 부합할 것입니다.

(다) 연구전담의 연구 성과 유도 제도적 장치 운영 미흡 관련

연구전담의 진료성과급 평가항목과 배점 개선 의견에 일부 동의 한다고 하면서도, 현행 평가항목과 점수 체계는 고득점 취득이 매우 어려운 구조로 연구전담의 업무 사기를 저하시킨다고 의견을 제시하였습니다.

그러나 현행 평가 구조는 획득 점수에 관계 없이 인원 배정 비율에 따라 성과급이 책정되는 구조로, 임용 다년차 포함 등 평가 대상자 전원이 지속적으로 #점에 가까운 점수를 받아도 성과급이 지급되거나 월등한 점수를 획득해도 저 성과자와의 성과급 차등이 크지 않아 연구에 대한 인센티브·패널티 요소가 미미한 상황이므로, 연구 성과 창출에 대한 동기를 유발할 수 있는 제도적 장치 보완이 필요할 것입니다.

5. 조치할 사항

○ ①병원장은

- ㉘ 특화 연구 성과가 부진한 연구전담의 운영의 기능 축소 및 진료과 전문의 겸직 운영 전환 등 연구성과가 임상진료, 의료정책에 반영되는 선순환 연구체제로 운영될 수 있도록 운영 체계를 개선 하시기 바랍니다. (권고)